

Výskyt zhubných nádorov v Slovenskej republike vrátane očakávaných prípadov za roky 1996 – 2024

NCZI v roku 2025 pokračovalo v publikovaní výstupov o očakávanej incidencii zhubných nádorov na základe algoritmu, ktorý na určenie nových prípadov onkologických ochorení využíva údaje zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti a údaje o príčinách úmrtí.

V najnovšej aktualizácii infografiky s názvom **Výskyt zhubných nádorov v Slovenskej republike vrátane očakávaných prípadov za roky 1996 – 2024** zo septembra 2025 bolo hodnotené obdobie pre očakávanú incidenciu zhubných nádorov rozšírené o roky 2023 a 2024. V rámci sledovaných ukazovateľov incidencie a úmrtnosti boli, v záujme zvýšenia porovnateľnosti údajov SR s inými krajinami či regiónmi, pridané nové prepočty vekovo-štandardizovaných mier na základe použitia dvoch ďalších štandardných populácií (novšia svetová štandardná populácia WHO na základe priemeru rokov 2000 – 2025 a staršia európska štandardná populácia z roku 1976) používaných v medzinárodnom kontexte. Aplikovanie štandardizácie eliminuje vplyv rozdielnej vekovej štruktúry obyvateľstva v priebehu rokov a zlepšuje tak porovnateľnosť údajov nielen medzi krajinami a regiónmi, ale aj pri porovnaní v čase. Infografika ponúka užívateľom možnosť výberu jednotlivých ukazovateľov pre hodnotenie údajov formou rozbaľovacieho zoznamu.

Infografika obsahuje vývoj incidencie zhubných nádorov v SR od roku 1996, v ktorom **roky 1996 – 2015 zobrazujú potvrdené prípady zhubných nádorov zo spracovania Národného onkologického registra SR a roky 2016 – 2024 predstavujú očakávané prípady zhubných nádorov identifikované na základe vyvinutého algoritmu z údajov zdravotných poisťovní**. Problematiku výskytu zhubných nádorov dopĺňajú údaje o úmrtnosti na zhubné nádory z údajov ŠÚ SR, rovnako za roky 1996 – 2024.

V časti infografiky venovanej osobitne diagnózam zaradeným do onkologických skriningových programov je možné sčasti sledovať efekt zavedenia populačných skriningových programov na výskyt karcinómu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka v populácii SR, pričom novinkou je dostupnosť údajov na územnú úroveň okresov.

V neposlednom rade prešla infografika aj vizuálnymi zmenami, najmä v usporiadaní filtrovacích prvkov s dôrazom na zrozumiteľnosť a prehľadnosť prezentovaného obsahu.

Pri porovnaní **vekovo-štandardizovanej miery incidencie**¹⁾, vzrástla incidencia zhubných nádorov (C00 – C96) od roku 1996 do roku 2024 takmer o 137 prípadov na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie, t. z. o 23,5 % (z 582,3 na 719,2 prípadov na 100 000). Nárast bol v sledovanom období výraznejší u žien (približne o 176 prípadov na 100 000 žien) ako u mužov (o 86 prípadov na 100 000 mužov). Muži však v celom sledovanom období dosahovali vyššiu mieru incidencie zhubných nádorov oproti ženám.

Úmrtnosť na zhubné nádory (C00 – C97) mala po roku 1996 klesajúcu tendenciu. V roku 2024 zomrelo na zhubné nádory 258,1 osôb na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie, čo bolo menej o 77,5 úmrtí na 100 000 osôb oproti roku 1996.

Pri hodnotení sumárnych údajov **očakávanej incidencie zhubných nádorov za sledované obdobie 2016 – 2024** dosiahla vekovo-štandardizovaná miera¹⁾ v SR hodnotu 690,1 prípadov na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie, pričom najvyššia bola v Bratislavskom kraji (758,2/100 000). Najnižšia očakávaná incidencia zhubných nádorov bola v Prešovskom kraji (647,5/100 000). Bydlisko (kraj, okres) bolo pacientovi pri vývoji algoritmu priradené podľa okresu najčastejšie navštíveného všeobecného lekára pre dospelých, resp. všeobecného lekára pre deti a dorast.

V období 2016 – 2024 sa u mužov, okrem *iných zhubných nádorov kože C44*, vyskytovali najčastejšie *zhubný nádor prostaty C61* (135,6 prípadov na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie), *zhubný*

¹⁾ako štandardná populácia bola použitá európska štandardná populácia z roku 2013, Eurostat

nádor hrubého čreva a konečníka C18 – C20 (104,7/100 000), zhubný nádor priedušnice, priedušky a pľúc C33, C34 (78,8/100 000). Zhubný nádor prostaty stúpol u mužov od roku 1996 o 91 prípadov na 100 000 mužov (zo 74,4 potvrdených prípadov v roku 1996 na 165,4 očakávaných prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie).

U žien sa po *iných zhubných nádoroch kože C44* vyskytovali najmä *zhubný nádor prsníka C50* (115,8/100 000 osôb európskej štandardnej populácie) a s väčším odstupom *zhubný nádor hrubého čreva a konečníka C18 – C20* (55,9/100 000), potom *zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice C54, C55* (36,8/100 000). *Zhubný nádor prsníka* u žien vzrástol od roku 1996 o 42,1 prípadov na 100 000 žien (z 80,9 potvrdených prípadov v roku 1996 na 123,0 očakávaných prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie).

Najvyššia očakávaná **vekovo-špecifická miera incidencie zhubných nádorov** bola v celom období 2016 – 2024 pozorovaná u mužov aj žien v najstarších vekových skupinách. U mužov sa v roku 2024 vyskytovalo 3 930,6 prípadov na 100 000 mužov vo veku 80 – 84 rokov; 3 866,6 prípadov na 100 000 mužov vo veku 75 – 79 rokov; 3 519,5 prípadov na 100 000 mužov vo veku 85 a viac rokov. U žien sa v roku 2024 vyskytovalo 2 328,9 prípadov na 100 000 žien vo veku 80 – 84 rokov; 2 151,8 prípadov na 100 000 žien vo veku 75 – 79 rokov; 2 140,2 prípadov na 100 000 žien vo veku 85 a viac rokov.

Prežívanie pacientov so zhubnými nádormi (C00 – C96) bolo hodnotené indexom prežívania. Ide o podiel počtu pacientov, ktorí sa dožili 1 roku, 3 rokov, resp. 5 rokov od dátumu diagnostikovania nádorového ochorenia a počtu novodiagnostikovaných prípadov nádorového ochorenia v roku diagnostiky. Do počtu prípadov neboli zaradené prípady identifikované len na základe úmrtia.

Z údajov zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti a údajov o úmrtiach vyplýva, že prežívanie pacientov do 1 roka od diagnostikovania choroby vzrástlo zo 79 % v roku 2016 na 81 % v roku 2023. Prežívanie do 3 rokov bolo aktuálne možné hodnotiť za roky 2016 – 2021, pričom v týchto rokoch dosahovalo úroveň 66 %, s výnimkou roku 2020 (64 %). Prežívanie do 5 rokov sa v rokoch 2016 – 2019, ktoré bolo možné hodnotiť, pohybovalo medzi 58 % a 59 %.

Pri hodnotení sumárneho počtu očakávaných prípadov zhubných nádorov za hodnotené obdobie 2016 – 2021 bolo prežívanie do 3 rokov najvyššie v Bratislavskom kraji (71 %), v ostatných krajoch SR sa pohybovalo medzi 64 % a 66 %. Prežívanie do 5 rokov dosiahlo najvyššiu úroveň tiež u pacientov z Bratislavského kraja (64 %). Vyššia ako celoslovenská hodnota bola ešte u pacientov z Prešovského kraja (60 %), kým v ostatných krajoch dosahovalo prežívanie do 5 rokov 56 % – 57 %.

Index prežívania klesá s vekom pacientov. Pri hodnotení sumárneho počtu prípadov zhubných nádorov diagnostikovaných v rokoch 2016 – 2019 dosahovalo prežívanie do 5 rokov u mladších osôb vo veku 30 – 44 rokov 84 %, u osôb vo veku 45 – 59 rokov 70 %, vo veku 60 – 74 rokov 59 % a u najstarších pacientov 75 a viacročných pacientov 40 %.

Najvyššie hodnoty indexu prežívania do 5 rokov boli, sumárne za obdobie rokov 2016 – 2019 v rámci hodnotených skupín diagnóz MKCH-10, zistené pri diagnózach: *zhubný nádor semenníka C62* (91 %), *zhubný nádor štítnej žľazy C73* (91 % pacientov), *iné zhubné nádory kože C44* (81 %), *zhubný nádor prsníka C50* (75 %), *zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice C54, C55* (73 %).

Najnižšie hodnoty prežívania do 5 rokov boli zistené pri zhubných nádoroch: *zhubný nádor pankreasu C25* (9 %), *zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žľazových ciest C22* (10 %), či *zhubný nádor žľazníka a žľazových ciest C23, C24* (13 %).

Zaujímavosťou je sledovanie vývoja **výskytu diagnóz zhubných nádorov, ktoré boli zaradené do onkologických skriningových programov** na Slovensku (karcinóm krčka maternice, kolorektálny karcinóm, karcinóm prsníka). Očakávaná vekovo-štandardizovaná miera incidencie¹⁾ *zhubného nádoru krčka maternice (C53)* u žien mierne klesla o 4,2 prípadu na 100 000 osôb (z 20,7 prípadov v roku 2016 na 16,5 prípadov v roku 2024 na 100 000 žien európskej štandardnej populácie). Na druhej strane, incidencia v štádiu *karcinómu in situ krčka maternice (D06)* od roku 2016 kontinuálne stúpala,

¹⁾ako štandardná populácia bola použitá európska štandardná populácia z roku 2013, Eurostat

výraznejšie po roku 2021 (z 14,2 v roku 2016 na 55,0 prípadov na 100 000 v roku 2024), čo pravdepodobne súvisí so zavedením celoplošného organizovaného skriningového programu karcinómu krčka maternice. Vo vekovej skupine žien 23 – 64 rokov oprávnenej na skrining bol nárast incidencie *karcinómu in situ krčka maternice* o 69 prípadov na 100 000 osôb pri porovnaní rokov 2016 a 2024.

Očakávaná vekovo-štandardizovaná miera incidencie¹⁾ *zhubného nádoru hrubého čreva a konečníka (C18 – C20)* klesla z 86,3 prípadov v roku 2016 na 73,1 prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie. Vo vekovej skupine oprávnenej na skrining kolorektálneho karcinómu 50 – 74 rokov klesla očakávaná incidencia *zhubného nádoru hrubého čreva a konečníka* zo 166,4 prípadov v roku 2016 na 140,2 prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie.

Očakávaná vekovo-štandardizovaná miera incidencie¹⁾ *zhubného nádoru prsníka (C50)* u žien mierne stúpala aj v období rokov 2016 – 2024, a to zo 114,2 na 123,0 prípadov na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie, zároveň stúpala aj očakávaná miera zachytených prekanceróz – *karcinómov in situ prsníka (D05)* z 8,9 na 13,8 prípadov na 100 000. V cieľovej vekovej skupine pre organizovaný skrining karcinómu prsníka 50 – 69 rokov, stúpala miera incidencie *zhubného nádoru prsníka* z 207,3 prípadov v roku 2016 na 223,1 prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie a miera incidencie *karcinómov in situ prsníka* z 20,3 prípadov v roku 2016 na 29,4 prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb európskej štandardnej populácie.

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v interaktívnej infografike zverejnenej na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy.

¹⁾ako štandardná populácia bola použitá európska štandardná populácia z roku 2013, Eurostat